

간호관리·보건의료

전문간호사의 마케팅·법적 의무, 관리과정(기획·조직·인력·통제), 조직·전문직 윤리, 보건의료자원과 진료비 지불제도, 국내·외 전문간호사 제도, 질 향상·환자안전, 환자교육과 건강행동 이론을 다루는 관리·법·제도·교육 영역이다.

이 계통의 질환·주제

- 마케팅(내부·관계 마케팅)
- 전문간호사의 법적 의무·책임
- 진단적 의료와 설명·동의 의무
- 윤리원리·전문직 통합·권력
- 관리과정(기획·조직·인력·통제)
- 전문간호사 프로그램 도입·팀 운영
- 보건의료자원·보건의료체계
- 진료비 지불제도
- 미국 전문간호사 제도
- 한국 전문간호사 제도·교육과정
- 질 평가지표·질향상·근거기반실무
- 전문간호사 역할(사례관리·상담자문·협력실무)
- 환자교육·학습목표
- 교육방법(e-learning·m-learning 등)
- 교육평가
- 건강행동 이론(범이론적 모형·건강신념모델)
- 프리셉터·간호이론·간호연구

1 마케팅 Internal / Relationship Marketing

내부마케팅 내부자인 직원을 잘 관리하여 더 좋은 성과를 내도록 **동기를 부여**하는 마케팅 활동.

관계마케팅 서비스 제공자가 소비자 등 이해관계자와 강한 이해관계를 형성·유지·발전시키는 과정으로, 장기간의 이익을 확보하기 위해 소비자와 대화하고 더 좋은 서비스를 제공하고자 하는 것.

예) 대한간호협회가 일반 대중을 상대로 공모를 통해 전문간호사의 이미지를 상징하는 로고에 투표하게 하고, 투표 참여자에게 추첨을 통해 선물을 준다.

역할 마케팅 전문간호사의 역할을 마케팅할 때 고려할 사항 중 하나는 **전문간호사임을 밝히는 것**. 내가 누구이고 무슨 일을 하는가를 전달하는 것이 기본이다. 자신을 전문간호사로 밝히고 대상자를 위해 무슨 일을 하는지를 설명한다.

2 전문간호사의 법적 의무·책임

확인 의무 간호사에게 자신의 역할을 위임한 전문간호사가 해당 간호사의 업무 수행 중 과정과 결과를 살펴봐야 하는 의무. 위임하였더라도 간호의 내용 및 그 행위가 정확하게 이루어지는가를 확인해야 할 의무가 있다.

민사책임(사용자 배상책임) 피고용인의 고용범위에서 발생한 과실에 대하여 고용주가 직접적인 책임을 지는 **사용자의 배상책임**이 있다.

3 전단적 의료와 설명·동의 의무

정의 전단적 의료란 의료인이 어떤 위험성이 있는 의료행위를 실시하기 전에 환자로부터 동의를 얻지 않고 의료행위를 하는 것, 즉 **설명 및 동의의 의무를 다하지 않은 것**이다. 따라서 전단적 의료 발생하지 않도록 전문간호사가 준수해야 할 의무는 **설명과 동의의 의무**이다.

설명의 의무가 면제되는 경우

- 환자가 설명 청취를 포기한 경우(알 권리를 가진 자가 그 권리를 유효하게 포기한 경우)
- 위험이 중대하거나 시간적으로 급한 경우(응급환자인 경우)
- 설명이 환자에게 악영향을 끼칠 것이 우려되는 경우
- 발생할 위험이 매우 비전형적이고 발생 개연성이 아주 희박한 경우
- 가정적인 승낙이 전제된 경우

주의 · 환자가 처치 및 검사를 거부하는 경우라도 **설명의 의무는 있다**.

4 윤리원리·전문직 통합·권력

- 안락사 관련 윤리원리·규칙**
- 평등의 원칙
 - 정직의 원칙
 - 정의의 원칙
 - 선행의 원칙

전문직 통합 전문직 통합은 윤리적 행위의 기초인 기본적 가치이다. 전문간호사는 환자·동료·고용인·본인의 전문직, 그리고 본인 등 다양한 대상자의 의무 사이에서 균형을 유지해야 한다. 고용인에 대한 의무가 있기는 하나 대상자(및 환자 가족)의 요구를 옹호할 의무도 가진다.

- 권력의 유형**
- **전문적 권력**: 특수한 능력·기술·지식을 내보임으로써 생기는 권력. 예) 새로 배치된 병동에서 오랜 기간 근무한 간호사의 말을 구성원이 잘 따르는 것 → 전문적 권력을 가진 비공식적 지도자.
 - **합법적 권력**: 어떠한 프로젝트의 팀 지도자로 공식 임명을 받으면 소유하게 되는 권력.

변화 추진력 각 병동에 전문간호사를 배치하는 것과 관련하여 발생할 수 있는 저항에 대응하며 변화를 계획할 때, 고려할 변화 추진력은 전문간호사 관련 법이다.

5 관리과정(기획·조직·인력·통제) Management Process

관리(개요) 전문간호사의 역할 중 관리는 조직의 목적 달성에 필요한 인적·물적 자원을 조달하고 조정하는 행위.

관리과정의 주요 기능

기능	내용·예시
기획(Planning)	특정 부서·분야의 이익을 위한 가장 효과적인 행동·사업을 결정하거나 영향을 예측·의사결정하는 과정. 시간·자원의 소비를 효과적으로 관리하여 원하는 산출(성과)을 얻도록 함. 예) 부서 운영예산 확보, 중환자실 인력·물품 관리. 안 위간호수행 항상 책임을 경력간호사에게 위임, 새 통증조절법 거부감에 대한 다학제적 토의 마련.
조직/지휘	예) 병동 운영에 필요한 예산 확보, 제안된 임상실험연구가 기관 자원에 미칠 영향 평가, 중환자 인권 위원회 구성 제안.
인력관리 (Staffing)	조직·구성원의 목적 달성에 필요한 인적 자원을 효율적으로 배치. 직원 채용·업무 분담 체계·구조를 설립하고 근무 스케줄을 결정·수정. 예) 병동 간호 조정자 직위 업무 규정 개발, 기계환기 환자 담당 간호사의 역량 열거.
통제 (Controlling)	수행 측정 기준을 설정하고, 결과를 보고하고, 교정 행위를 취하며, 임상적·재정적 결과를 감독. 예) 전문간호사의 항암 투약행위가 기관 표준에 부합하는지 관찰.

인력 산정·팀 사정

- 소아병동 운영에 필요한 직원 수 판단 시 필요한 자료: 환자의 유형·수, 중증도, 제공할 간호의 복잡성.
- 새로운 팀 형성 시 방해를 최소화하기 위해 반드시 사정할 내용: 팀 내 개인 구성원의 역할과 상호관계 유형.
- 새로운 세팅의 장비·소모품 확인 방법: 전문간호사의 전문성, 가이드라인, 매뉴얼, 표준장비 목록, 타 의료진과의 협조. (과거 경험 의존은 적절치 않음)

시험 포인트 · MBO(목표관리)는 프로그램의 효과·목적 달성도를 평가할 때 가장 적합한 방식으로, 설정한 목적이 성취되었는지에 초점을 둔다.

6 전문간호사 프로그램 도입·팀 운영

공식 구조 확인 • 프로그램 첫 도입 시 병원의 공식적 구조를 확인하는 가장 좋은 방법: 조직의 철학·미션·가치 등을 검토.

- 프로그램 계획의 첫 단계: 새 프로그램이 적용되거나 기존 프로그램이 수정될 환경에 대한 정보를 수집하여 필요한 점을 결정하는 상황평가(요구사정) 실시.

병원 간 연계 프로그램 조정 책임자로서 초기에 취해야 할 조정 행위는 참여 병원의 전문의·전문간호사·병동 직원들과 인간적 관계를 형성하는 것. 변화의 성공적 정착을 위해 주요 관계자를 확인하고 개인적 관계를 형성하여 이들이 적극 참여하도록 이끈다.

팀 규범·갈등·응집력 • 규범은 그룹 행동의 범위를 처방하고, 구성원이 자유롭게 참여할 신뢰를 형성하여 팀의 지속성·예측성을 확보한다.

- 직종 간 갈등이 있는 경우 다학제 구성원의 합의를 통해 해결책을 제시한다.
- 응집력을 방해하는 것은 안정적이지 않은 구성원 자격. 기대에 미치지 못한다고 대체할 사람을 찾는 것은 구성을 저해하는 행동이다.

7 보건의료자원·보건의료체계

보건의료제도 구성요소

- 보건의료조직
- 보건의료관리
- 의료전달체계
- 자원조달

※ 보건의료인력은 보건의료자원 중 하나이다.

보건의료전달 체계(보건의료 체계)

제한된 보건의료자원을 효율적으로 활용하여 국민에게 동등한 수준의 의료와 접근도를 유지함으로써 국민건강의 최대화를 달성하고자, 보건의료자원의 조화를 통해 의료서비스 전달을 체계화하는 것. 목적은 국민에게 적절한 의료를 체계적·효율적으로 제공하는 것이다.

우리나라 보건 의료체계의 특 성

- 보건인력 공급의 탄력성이 낮다
- 고가의 의료장비 및 병상이 과잉공급되어 있다
- 의료기관 종별 기능이 명확하지 않게 운영된다
- 의료기관 양극화 현상이 발생한다
- 민간의료 중심으로 보건의료가 공급된다

자원 배치 관련 사항

- 의료보험 프로그램으로 의료보험이 있다
- 관리(결제)기관은 비정부기관이다
- 비정부기관으로 각종 보건관련 단체가 있다
- 독립적 민간부분으로 의사·치과의사 등이 있다
- 국가보건의료 당국으로 보건복지부가 대표적이다

시험 포인트 · 우리나라 전국민의료보험 실시: 1989년. 보건의료제도 유형 — 한국: 전국민사회보험형 / 영국: 조세형 / 미국: 민간보험형.

8 진료비 지불제도

진료비 지불제도 비교

제도	내용	특징
인두제	일정 지역 주민(등록된 환자·사람) 수에 일정 금액을 정해 보수를 지급. 등록 수만큼 사전 결정된 수입을 보장받고 일정 기간 의료서비스 제공.	상대적으로 저렴, 예방에 관심 증가 / 환자의 선택권 제한.
행위별 수가제	약제·재료비를 별도 산정하고 진료행위 하나 하나마다 항목별 가격을 책정. 단위당 가격 × 서비스 양만큼 보상.	짧은 시간에 많은 환자 진료, 새 의료기술 도입·연구 촉진 / 과잉 진료·과잉 투약 소지.
포괄수가제	한 가지 치료행위가 아니라 어떤 질병으로 입원했는가에 따라 질병군(환자군)별 미리 책정된 일정액을 지급. 환자 종류당 총괄보수단가 설정.	경제적 진료 유도, 의료기관 생산력 증대, 행정 간편 / 서비스 양 최소화·규격화 우려.
보급제	사회주의 국가·영국 같은 국영의료체계 병원급 근무의에게 적용. 일정 기간에 따라 보상.	벽지·오지 주민도 쉽게 의료이용 / 진료수준은 낮은 편, 불필요한 경쟁 억제.
총액계약제 (총괄계약제)	보험자 측과 의사단체(보험의협회) 간에 진료비 총액을 추계·협의 후 사전에 결정된 총액을 지급. 독일의 보험의에게 적용.	총진료비 억제 가능 / 매년 계약 필요, 새 기술 도입에 제한.

9 미국 전문간호사 제도

특징

- 전문간호사의 역할이 간호법에 분명히 명시되어 있다
- 법적 책임과 권한을 가진다
- 전문간호사 실습교육이 전문간호사의 지도 하에 이루어진다
- 전문간호사의 자격·면허·갱신 등에 대한 통합관리부서를 가지고 있다
- 주별로 면허 법령과 규정이 있다

미국 전문간호사 종류 마취전문간호사, 임상전문간호사, 전문실무간호사, 조산전문간호사.

10 한국 전문간호사 제도·교육과정

국내 도입 배경

- 보건의료분야의 전문화 추세
- 전공의 부족, 낮은 의료수가 해결
- 국민의 의료서비스 기대수준 부응, 전문 지식·술기 요구도 부응
- 의료기술 발전, 인구·질병 구조 변화로 의료 이용 증가

제도 정립을 위한 사항

- 전문간호사 핵심능력 강화
- 전문간호사 영역 중복 문제 해결
- 전문간호사 분야별 역할 규정의 타당성 검증
- 전문간호사와 간호사 간 역할 차별화 및 정체성 확립

교육과정 기준

- 공통 필수학점: 13학점 이상
- 전공 실습: 300시간 이상
- 교육기간: 2년 이상
- 전공이론: 10학점 이상
- 입학 시: 최근 10년 이내 해당분야 3년 이상 실무경력 필요

시험 포인트 · '분야별 간호사'→'전문간호사'로 의료법 개정: 2000년. '전문간호사 자격인정 등에 관한 규칙' 제정: 2006년. 자격시험 관리기관: 한국간호교육평가원. 영역(13개): 보건·마취·정신·가정·감염관리·산업·응급·노인·중환자·호스피스·종양·임상·아동.

질 평가지표

지표	내용
구조지표	간호전달 과정에서 사용된 인력·장비·자원을 측정. 예) 전문간호사 대 총 간호사 비율, 간호사-환자 비율, 환자당 간호시간.
과정지표	간호를 전달하는 치료제공자의 행동·태도 측정. 대상자와의 대면·대화 포함, 중재와 결과 사이 인과관계를 밝히는 요소. 예) 병원감염 예방을 위한 의료인의 손씻기 수행여부 조사.
결과지표	사람·집단·기관·공동체에 대한 행동·중재의 효과 근거. 서비스를 제공받은 이들에 대한 변화를 나타내며, 제공자에 대한 지표는 아니다.

질향상(QI) 활동

보다 나은 질적 서비스 제공을 위한 활동. 문제의 원인·관련요인을 규명하고 효과적 개선과제를 찾아야 한다. 환자안전 활동 모니터링 중 일부 간호사가 지침을 지키지 않는 것을 목격하면, 일단 모니터링을 진행하고 결과를 분석한 후 개선방안을 강구한다.

전문간호사가 지속적 질 향상 수행 시 도달 가능한 목표: 과실 위험 감소, 환자 간호 성과 평가도구 제시, 간호수행 기록의 향상, 실무 능력 강화.

근거기반실무(EBP)

개별 환자 간호를 결정할 때 명백하고 신뢰성 있는 최신의 연구기반 근거를 사용하는 것. 전문간호사에게 EBP 수행을 위한 연구역량 강화가 요구된다.

EBP 단계: 임상질문 → 근거검색 → 비평적 분석 → 실무적용 → 평가.

관련 연구

역할 기술 연구: 전문간호사의 직업 특성과 역할을 설명·정의하는 데 중점. 전문간호사 역할이 간호전달 결과에 기여한다는 이론적 발전을 이끌어 내기 위한 증거로 이용.

12 전문간호사 역할(사례관리·상담자문·협력실무)

사례관리	진료의 질을 높이고 재원일수 감소를 통해 비용효과를 얻고자 함. 건강관리 체계 내에서 연속성 있는 서비스 제공을 목표로 한다. 전문간호사에게 갈수록 강조되는 역할.
상담자문	상담가가 전문화된 지식을 가졌다고 인정되는 두 전문가 사이의 상호작용. 기록되어야 하며, 상담가는 처방이 아니라 권장을 한다. 둘 사이 관계는 위계적이지 않고 협력적이며, 일반적으로 의뢰자에 의해 시작 된다.
협력적 실무 모델	케어 제공 시 환자의 필요가 최우선이어야 한다는 것이 핵심 원칙. 의사와 전문간호사 모두 환자를 사정하고 요구도에 따라 관리계획·수행까지 함께 한다.
역할 모순	기술·능력과 역할 의무가 비양립적이거나, 개인적 가치·자아와 역할 의무가 비양립적인 역할. 예) 소아 병동에 배치된 성인 전문간호사가 경험하는 역할 개념(역할 내부의 마찰).
기대하는 간호 성과	상급간호실무에서 기대하는 성과: 대상자의 합병증 감소, 대상자·가족의 만족도 증가, 재원기간 단축, 약물복용 이행 증진.
정보관리·기획 부가사항	- 휴대폰·태블릿 PC 등 휴대용 기기의 가장 큰 이익: 정보 접근 시간 단축, 업데이트된 정보 이용으로 오류 감소, 간호 계획 시간 증가로 서비스 향상. - 사업프로그램 계획 시 수입에 포함되는 항목: 예상 수입, 창업 대출금, 환자로부터 받는 진료비, 국민건강보험·장기요양보험 환급금. - 환자 교육 향상을 위한 지속적 노력 직무 → 질향상 역할을 요구하는 것.

13 환자교육·학습목표

학습목표	환자 교육 계획 시 학습목표는 환자의 배울 행동(학습 후 행동)을 기술해야 한다. 학습목표 영역: 인지적 영역, 정의적 영역, 심리운동적 영역. 정의적 영역은 학습자의 태도·감정·느낌 등과 관련된 부분이다.
학습목표의 조건	논리적으로 기술, 실현가능성·측정가능성이 있는 목표 설정, 학습자·교육자 모두 명확히 이해하고 이에 기준하여 교수-학습이 일어날 수 있도록 명확하게 설정.
성인학습이론	전문간호사는 환자·가족의 건강교육 계획·수행 시 성인학습이론을 적용한다. 성인학습은 생애 전반의 경험을 지식·태도·가치·정서와 함께 행동변화로 전환시키는 활동으로, 자기주도학습 등을 통해 학습자 스스로 학습할 동기와 역량을 키워주는 것이 중요하다.
보건교육·요구사정	• 보건교육: 지식 전달에 그치지 않고, 건강은 자기 스스로 지켜야 한다는 긍정적 태도를 가지고 올바른 행동을 일상생활에서 습관화하도록 돕는 교육과정. • 보건교육 계획 시 가장 먼저 할 일: 환자의 요구도 확인.

14 교육방법(e-learning·m-learning 등)

컴퓨터 보조학습(CAI) 컴퓨터를 활용하여 실제 수업과 유사한 과정을 제공하는 교육방법. 학습자 개개인에 맞는 수준·속도로 학습 기회 제공. 학습자와 컴퓨터가 상호작용하며 교사는 학습의 보조자·조력자 역할.

e-learning vs m-learning

	e-learning(이러닝)	m-learning(엠러닝)
매체	웹 기술과 인터넷을 이용. 부호데이터·정지 영상·동영상·음악·음성 등 여러 형식의 데이터를 통합 제공.	휴대용 컴퓨터·휴대폰 같은 모바일 기기를 활용한 교육방법.
공통 장점	시간·장소에 구애받지 않고 개별학습이 가능하다.	

역할극 환자·보호자 간 가족 내 의사소통 문제와 갈등이 클 때 가장 적합한 교육전략. 상대방의 입장을 이해하고 효율적 의사소통·문제해결 방식을 학습할 수 있다.

교육방법 선정 영향 요소 교육일자, 교육대상자 수, 학습목표의 난이도, 교육 장소·시설, 교육참여자들의 교육수준. 이 중 가장 영향력이 적은 요소는 교육일자.

15 교육평가

교육평가 방법

평가	시점·목적
진단평가	교육 시작 전, 학습자의 준비도를 알아보기 위한 평가.
형성평가	학습 중간에 학습 효과 파악 또는 피드백을 위해 수행.
총괄평가	과정·프로그램 완료 후 학습성과를 평가.

16 건강행동 이론

범이론적 모형 개인이 어떻게 건강행동을 시작하고 유지하는가에 대한 행동변화의 원칙·과정을 설명하는 통합적 모형. 단계: 계획이전단계 → 계획단계 → 준비단계 → 행동단계 → 유지단계.

건강신념모형 건강행위를 수행할 준비에 관한 예측이론으로 많이 사용. 질병의 민감성·심각성·위협성에 대한 개인의 신념뿐 아니라, 건강관리 행위에 대한 유익성·장해성에 대한 신념에 근거한다. 건강동기와 자기효능감은 건강행위 실천을 높이는 개념으로 중요도가 높다.

17 프리셉터·간호이론·간호연구

프리셉터 경험 있는 실무자와 초보자가 일대일·단기간 계약하는 공식적 관계. 전문간호사는 프리셉터 프로그램을 기획하고, 프리셉터로서 기능도 하며, 프리셉터 선발·훈련·평가 과정에 참여한다.

간호이론

- 적응이론
- 뉴먼의 체계모형(저항선, 정상방어선, 유연방어선 등)

간호연구

- 표본추출(샘플링) 방법
- 통계방법
- 간호연구 오류(2번째 측정 시 점수가 상승되는 것과 관련된 오류)

본 노트는 PDF를 300dpi로 렌더링 후 한국어 OCR(EasyOCR)로 추출한 텍스트를 의학용어 기준으로 교정·재구성한 자료입니다. OCR 특성상 일부 수치·표기에 오차가 있을 수 있으니 원문과 교차 확인하세요. 페이지 스캔 이미지는 각 항목의 [원문] 링크/그림에서 확인할 수 있습니다.